



Beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica

Opvolging 2025 van de aanbevelingen





Rekenhof

Beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica

Opvolging 2025 van de aanbevelingen



Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 7 januari 2026

1	Context	5
2	Initiële audit van 2022	6
2.1	Beschikbare gegevens	6
2.2	Omkadering van het voorschrijfgedrag	6
2.3	Omkadering van de aflevering	6
2.4	Nationaal actieplan 2020-2024	6
2.5	Conclusies van de audit van 2022	7
3	Opvolgingsmethode en tijdschema	7
4	Uitvoering van de aanbevelingen	8
4.1	Doelstellingen, indicatoren en beschikbare gegevens	8
4.2	Acties in verband met het voorschrijfgedrag	10
4.3	Acties in verband met de aflevering	16
4.4	Nationaal actieplan voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie	17
5	Conclusies	18

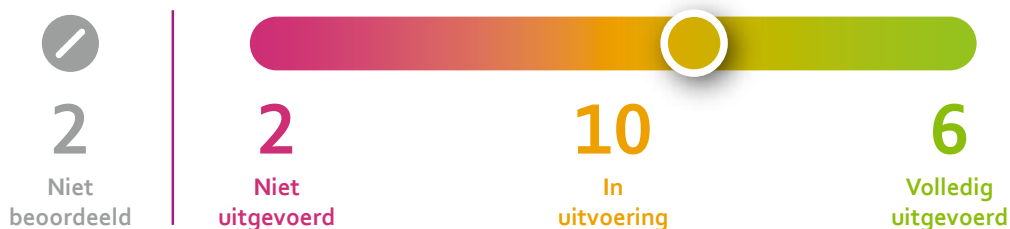
Beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica: opvolging 2025 van de aanbevelingen

In 2022 onderzocht het Rekenhof het beleid voor het voorschrijven en afleveren van antibiotica dat de FOD Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voerden. Het controleerde of dit beleid in overeenstemming was met de nationale en internationale aanbevelingen en of het gebruik van antibiotica was gedaald.

Hoe groter het gebruik van antibiotica, hoe resistenter de bacteriën en hoe minder doeltreffend de werking van die antibiotica. Zonder doeltreffende antibiotica kunnen veel infecties, waarvan sommige dodelijk zijn, echter niet meer worden genezen, wat leidt tot kosten voor de sociale zekerheid, met name kosten voor ziekenhuisopnames. Een efficiënte oplossing om de resistentie van bacteriën te beperken, is verstandig omspringen met antibiotica en de goede klinische praktijken volgen.

Ondanks een innovatief beleid in 1999 was België in 2019 nog steeds een van de grootste antibiotica-gebruikers in Europa. Een efficiënte omkadering voor het voorschrijven en afleveren van antibiotica ontbrak, evenals nauwkeurige gegevens over de verstrekte antibiotica en over de doeltreffendheid van de maatregelen om de afgeleverde hoeveelheden te beperken. Het percentage van sommige antibiotica die werden afgeleverd en waarvan het gebruik volgens de nationale en internationale normen zou moeten worden ingeperkt, bleef overigens te hoog. Die antibiotica kunnen echter soms onomkeerbare invaliderende bijwerkingen hebben.

In het kader van zijn opvolging in 2025 onderzocht het Rekenhof of de aanbevelingen uit zijn initiële audit van 2022 waren uitgevoerd. Het concludeert dat zes aanbevelingen zijn uitgevoerd, tien gedeeltelijk zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn, twee niet zijn uitgevoerd en twee niet kunnen worden beoordeeld.



Volgens de laatste beschikbare gegevens (juni 2024 - mei 2025) is het aantal terugbetaalde antibiotica met 8 % gedaald ten opzichte van 2019. Dat kan het gevolg zijn van de indicatoren voor goede praktijken die het RIZIV eind 2023 heeft gepubliceerd en van andere RIZIV-acties. Veel antibiotica worden echter voorgeschreven buiten de terugbetalingsvoorwaarden om. Het aandeel ervan ten opzichte van de terugbetaalde antibiotica stijgt van 11 % in 2019 tot 12 % in 2023. Bovendien werd in 2023 het merendeel van bepaalde antibiotica met mogelijk aanzienlijke bijwerkingen voorgeschreven buiten de terugbetalingsvoorwaarden en dus buiten het controledomein van het RIZIV.

1 Context

Bacteriële resistentie tegen antibiotica veroorzaakt infecties die moeilijk te genezen zijn en leiden tot hospitalisatie, nawerkingen en honderden doden per jaar in België, en dus ook tot aanzienlijke overheidsuitgaven. Volgens het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (*European Centre for Disease Prevention and Control*, ECDC) zouden de financiële gevolgen 24 euro per persoon per jaar bedragen in Europa¹. Voor België betekent dat 281 miljoen euro². 56 % daarvan (of 158 miljoen euro) heeft betrekking op uitgaven voor gezondheidszorg (vnl. ziekenhuisopnames) en 44 % (122 miljoen euro) op economische verliezen (onder meer arbeidsongeschiktheid en productiviteitsverlies).

Onnodig gebruik van antibiotica vergroot de resistentie van bacteriën. Omgekeerd kan met een doeltreffend beheer van het gebruik ervan in een land die resistentie worden tegengegaan en zo het aantal ongeneeslijke infecties en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen worden beperkt. In Nederland, waar het antibioticagebruik in 2019 2,6 keer lager lag dan in België, is de bacteriële resistentie ook lager.

Zoals vermeld in de audit van 2022 van het Rekenhof³, zijn de geraadpleegde nationale en internationale bronnen unaniem: om de resistentie van bacteriën te bestrijden, moet verstandig worden omgesprongen met antibiotica, d.w.z. dat ze enkel mogen worden voorgeschreven en afgeleverd als het noodzakelijk is volgens de goede klinische praktijken die berusten op feitelijke gegevens. Die bronnen verwijzen ook wel naar de goede praktijken als ‘klinische praktijkrichtlijnen’⁴, ‘evidence-based richtlijnen’⁵ of ‘evidence-based guidelines’⁶.

In de jaren 90 was België één van de grootste antibioticaverbruikers in Europa. Om het overmatige gebruik van die geneesmiddelen een halt toe te roepen, bouwde ons land in 1999 een beleid uit dat op Europees vlak vernieuwend was. Niettemin was België twintig jaar later nog steeds één van de grootste antibioticaverbruikers in Europa. De doelstellingen van het beleid waren dus niet gehaald.

Het Rekenhof stelde vast dat de FOD Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) nochtans over de wettelijke middelen beschikten om een doeltreffend beleid op te zetten om het gebruik van die geneesmiddelen in België te verbeteren, de bacteriële resistentie te beperken en de uitgaven voor gezondheidszorg en de daaruit voortvloeiende economische verliezen te verminderen.

1 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), *Bestrijding van resistentie tegen antimicrobiële stoffen: doelstellingen voor 2030*, 2023, 8 p., www.ecdc.europa.eu.

2 Statbel, *Bevolking per gemeente op 1 januari 2023*, www.statbel.fgov.be.

3 Rekenhof, *Beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica*, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 2022, 69 p., rekenhof.be.

4 BAPCOC, *Beleidsnota legislatuur 2014-2019*, Brussel, 2014, 50 p., www.health.belgium.be.

5 Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE), R. Leroy et autres, *Proposals for a More Effective Antibiotic Policy in Belgium*, Bruxelles, 2019, 386 p., www.kce.fgov.be.

6 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), *ECDC Country Visit to Belgium to Discuss Antimicrobial Resistance Issues. Mission report*, Stockholm, juli 2018, 35 p., www.ecdc.europa.eu.

2 Initiële audit van 2022

2.1 Beschikbare gegevens

Om de doeltreffendheid van het overheidsbeleid te kunnen evalueren, moeten er nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn over het voorschrijven en afleveren van antibiotica.

De gegevens die beschikbaar waren toen de audit van 2022 werd uitgevoerd, hadden echter uitsluitend betrekking op de terugbetaalde geneesmiddelen, terwijl 11 % van de antibiotica in de apotheek was afgeleverd zonder terugbetaling. Bovendien gebruikte het RIZIV geen gegevens over de voorschriften per voorschrijver om de doeltreffendheid van zijn acties te evalueren. Het Rekenhof formuleerde in zijn audit de aanbeveling om nauwkeurige gegevens te gebruiken door zich enerzijds te baseren op de aflevering van antibiotica in openbare apotheken en anderzijds op antibioticavoorschriften per voorschrijver.

2.2 Omkadering van het voorschrijfgedrag

Toen de audit van 2022 liep, had het RIZIV maatregelen ingevoerd om de opvolging van de goede praktijken te verbeteren. Zo had het de voorschrijvers informatie bezorgd over de voorschriften, en de voorwaarden veranderd waaronder antibiotica werden terugbetaald. Niets wees er echter op dat die maatregelen effectief waren. Integendeel, uit de beschikbare gegevens over de hoeveelheid en de kwaliteit van de voorschriften bleek dat de goede praktijken beter gevolgd moesten worden. Daarnaast werden veel nationale en internationale aanbevelingen niet opgevolgd, zoals het beschikbaar stellen van hulpmiddelen om voorschrijvers te helpen bij het kiezen van het juiste antibioticum, en de controle op de voorschrijvers die de meeste antibiotica voorschrijven. Het Rekenhof formuleerde de aanbeveling om de nationale en internationale aanbevelingen uit te voeren zodat de kwaliteit van antibioticavoorschriften zou verbeteren en de afgeleverde hoeveelheden zouden verminderen.

2.3 Omkadering van de aflevering

Ten tijde van de controle in 2022 bevatten de dozen antibiotica die in openbare apotheken werden verkocht vaak meer doses antibiotica dan nodig waren voor een behandeling, waardoor onnodige doses antibiotica werden verstrekt. Daarnaast leverden apothekers sommige antibiotica zonder voorschrift af. Dus zelfs wanneer de voorschrijvers de goede praktijken toepasten, werden talrijke nodeloze antibiotica afgeleverd. In 2022 beval het Rekenhof aan de afgifte van de exact benodigde hoeveelheid verplicht te stellen voor de ambulant verstrekte antibiotica. Het beval ook aan de aflevering te controleren om na te gaan of de apotheker steeds een voorschrift vroeg voordat hij het antibioticum verstreekte.

2.4 Nationaal actieplan 2020-2024

De betrokken ministers op federaal en regionaal niveau valideerden in november 2021 een nationaal actieplan 2020-2024 voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie⁷. Het doel van het plan was om het Belgische antibioticabeleid te verbeteren. Het beantwoordde aan de nationale en internationale aanbevelingen die ervoor pleitten een plan op te stellen waarbij de sectoren werden betrokken die te maken hadden met antibioticagebruik (gezondheid van mens en dier, milieu).

7 FOD Volksgezondheid en andere, *Belgisch nationaal actieplan "One Health" voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie 2020-2024*, Brussel, 2021, 49 p., www.health.belgium.be.

Het plan bood echter geen oplossingen voor de vaststellingen van de audit, onder meer voor het ontbreken van evaluatie en controle van het voorschrijfgedrag en de aflevering van antibiotica. Bovendien was er geen sprake van het evalueren van de doeltreffendheid van de aanbevolen maatregelen om de kwaliteit van het voorschrijfgedrag en van de aflevering te verbeteren. Een verspilling van middelen door het doorvoeren van ondoeltreffende acties kon dan ook niet worden uitgesloten. Het Rekenhof beval aan om de aanbevelingen van de audit in het plan op te nemen. Het formuleerde ook de aanbeveling na te gaan of elke maatregel doeltreffend was om de doelstelling van het verstandige gebruik van antibiotica te bereiken.

2.5 Conclusies van de audit van 2022

De nationale en Europese doelstellingen voor het voorschrijven en verstrekken van antibiotica werden niet gehaald ten tijde van de audit van 2022. Het risico bestond dat dit in de toekomst ook niet het geval zou zijn, tenzij doeltreffende maatregelen werden genomen en de impact ervan werd geëvalueerd. De kwaliteit van de voorschriften controleren, en verplichten dat de exacte hoeveelheid antibiotica wordt afgeleverd, behoorden tot die maatregelen. Ondanks het feit dat de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG er de middelen toe hadden, hebben ze geen voldoende doeltreffende maatregelen genomen.

3 Opvolgingsmethode en tijdschema

In december 2025 is het Rekenhof nagegaan welk gevolg was gegeven aan zijn aanbevelingen. Daartoe bevroeg het de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG en de beleidscel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Om een gedocumenteerde stand van zaken op te stellen over de uitvoering van zijn aanbevelingen van 2022, stuurde het hen op 27 augustus 2025 per mail een vragenlijst. De FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG stuurden een gezamenlijk antwoord op 30 september 2025. De beleidscel van de minister heeft niet geantwoord.

Op 23 oktober 2025 stuurde het Rekenhof, in het kader van de tegensprekelijke procedure, een ontwerp van opvolgingsverslag naar de administratie, de twee bovenvermelde instellingen en de beleidscel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Hun commentaar werd verwacht tegen 24 november 2025. Het RIZIV en het FAGG hebben op 21 november 2025 geantwoord. Het Rekenhof heeft die antwoorden geanalyseerd en er rekening mee gehouden bij de opmaak van dit verslag.

Het Rekenhof is in dit opvolgingsverslag nagegaan welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen. Het kende een kleurcode toe aan elke aanbeveling op basis van de mate waarin ze werd uitgevoerd. In het [punt 4](#) hieronder staat telkens naast de aanbevelingen vermeld aan wie ze zijn gericht; eronder volgt een samenvatting van de bevindingen van de initiële audit. De bewijskrachtige gegevens waarop die vaststellingen zijn gebaseerd, zijn te vinden in het auditverslag van 2022⁸.

⁸ Rekenhof, *Beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica*, op.cit.

	Volledig uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd
	Niet beoordeeld

Dit verslag is gebaseerd op een vereenvoudigde opvolging, uitgaande van de verklaringen van de geauditeerden en de documenten die ter ondersteuning daarvan werden verstrekt. Het Rekenhof heeft geen auditwerkzaamheden verricht (zoals gesprekken, tests en grondige analyse van documenten) om de kwaliteit van de ontvangen documenten en de getroffen maatregelen te beoordelen.

4 Uitvoering van de aanbevelingen

De uitvoering van de aanbevelingen wordt hieronder uiteengezet in vier subpunten, die overeenkomen met de thema's van het auditverslag van 2022:

- doelstellingen, indicatoren en beschikbare gegevens;
- acties in verband met het voorschrijfgedrag;
- acties in verband met de aflevering;
- nationaal actieplan voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie.

4.1 Doelstellingen, indicatoren en beschikbare gegevens

Aanbeveling 1

Stel een regelgevend kader op zodat het RIZIV over precieze gegevens kan beschikken met betrekking tot alle antibiotica die in de ambulante zorg worden afgeleverd (al dan niet terugbetaald, al dan niet voorgeschreven).

Minister,
RIZIV



Tijdens de initiële audit in 2022 had het RIZIV toegang tot precieze gegevens, maar alleen over terugbetaalde antibiotica. Verder beschikte het over het aandeel niet-terugbetaalde, afgeleverde antibiotica in het geheel van de verstrekte antibiotica, via een database van de geneesmiddelen die werden afgeleverd door de apothekers en tegen betaling werd ter beschikking gesteld. Uit deze gegevens bleek dat sommige antibiotica waarvoor terugbetalingsvoorwaarden gelden, zoals chinolonen⁹, het vaakst buiten de terugbetalingsvoorwaarden om werden voorgeschreven. Aangezien die terugbetalingsvoorwaarden een manier zijn om voorschrijvers aan te moedigen om goede praktijken na te leven, voldeed een deel van de zonder terugbetaling afgeleverde voorschriften waarschijnlijk niet aan deze voorwaarden. Zonder precieze informatie over die voorschriften kon het RIZIV de betrokken voorschrijvers niet controleren.

In zijn antwoord op de vragenlijst voor de opvolging vermeldt het RIZIV dat het sinds 2025 toegang heeft tot de gegevens van Farmaflux, een vzw die is opgericht door apothekersverenigingen om apotheekgegevens te beheren¹⁰. Die gegevens bevatten gedetailleerde informatie over verstrekte antibiotica (al dan niet terugbetaald). Het RIZIV verwerkt momenteel de gegevens van 2024,

⁹ • Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), *Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium. Chinolonen*, pagina geraadpleegd op 7 november 2025, www.bcfi.be.

• De term 'fluorochinolonen' (een soort chinolonen) wordt soms gebruikt in plaats van chinolonen.

¹⁰ Farmaflux, *Over Farmaflux*, pagina geraadpleegd op 13 november 2025, www.farmaflux.be.

het eerste jaar dat beschikbaar is. Er is een wijziging in de regelgeving gepland om Sciensano rechtstreeks toegang te geven tot de Farmaflux-gegevens. In zijn reactie op het ontwerp van opvolgingsverslag voegt het RIZIV eraan toe dat die gegevens moeten voldoen aan kwaliteitscriteria die zijn vastgelegd in zijn overeenkomst met Farmaflux¹¹.

Hoewel toegang tot deze database beantwoordt aan de aanbeveling van het Rekenhof, stelt het vast dat, aangezien de Farmaflux-gegevens anoniem zijn, het niet mogelijk is de voorschrijver te identificeren, wat noodzakelijk is om de voorschriften voor antibiotica die buiten de terugbetalingsvoorwaarden zijn afgeleverd, te analyseren en controleren.

Aanbeveling 2

Bezorg aan Sciensano gegevens over alle antibiotica die in de ambulante zorg worden afgeleverd, zodat Sciensano die informatie kan doorgeven aan het ECDC.

RIZIV



Ten tijde van de initiële audit in 2022 kon het RIZIV het aandeel antibiotica dat in 2019 werd verstrekt (al dan niet terugbetaald) berekenen via de tegen betaling ter beschikking gestelde database over de afgeleverde antibiotica. Voor België heeft het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (*European Centre for Disease Prevention and Control*, ECDC) echter alleen gegevens gepubliceerd over terugbetaalde antibiotica. De niet-terugbetaalde antibiotica waren evenwel goed voor 11 % van alle verstrekte antibiotica in 2019. De hoeveelheid gebruikte antibiotica in België werd daarom onderschat, terwijl veel andere Europese landen, zoals Nederland, gegevens rapporteerden over alle afgeleverde antibiotica.

In zijn antwoord op de vragenlijst voor de opvolging stelt het RIZIV dat het de gegevens 2023 over de terugbetaalde antibiotica en over het aandeel verstrekte maar niet terugbetaalde antibiotica heeft bezorgd aan Sciensano. Ook de gegevens 2024 van de vzw Farmaflux zouden aan Sciensano zijn bezorgd en er zou een regelgeving op komst zijn om Sciensano rechtstreeks toegang te geven tot die gegevens.

Het aandeel antibiotica dat in 2023 werd verstrekt maar niet werd terugbetaald, komt wel degelijk voor in het laatste verslag over antimicrobiële middelen¹² van Sciensano. Het Rekenhof merkt echter op dat het ECDC voor België enkel gegevens heeft gepubliceerd over terugbetaalde antibiotica¹³. De publicatie van die gegevens komt neer op een onderschatting met 12 % van het antibioticagebruik in België in 2023¹⁴. Rekening houdend met dat percentage stond België niet op de 18^e, maar op de 21^e plaats van de 27 Europese landen gerangschikt in oplopende volgorde van het antibioticagebruik. Slechts zes Europese landen gebruikten dus nog meer antibiotica. Desondanks daalde het aantal verstrekte antibiotica in België tussen 2019 en 2023, met 3,2 % wat betreft de terugbetaalde antibiotica en met 2,4 % wat betreft alle, al dan niet terugbetaalde, antibiotica¹⁵.

11 Overeenkomst "Artikel 56 §1" van 6 september 2024 tussen het RIZIV en Farmaflux, per e-mail meegedeeld aan het Rekenhof op 21 november 2025.

12 Sciensano, Belmap 2024, *One Health Report of Antimicrobial Consumption and Resistance in Belgium*, Brussel, 2024, 114 p., www.health.belgium.be.

13 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), *Antimicrobial Consumption in the EU/EEA (ESAC-Net). Annual Epidemiological Report 2023, Stockholm*, november 2024, www.ecdc.europa.eu.

14 RIZIV, *Geneesmiddelenverbruik in openbare officina's. Antibiotica – Alle voorschrijvers. Analyse van de verdeling en van de evolutie van het verbruik in volumes en in uitgaven per verzekerde in België (analyses en tendensen per gewest, provincie en arrondissement) voor 2023*, 2 november 2024, 46 p., www.gezondbelgie.be.

15 Sciensano, Belmap 2024, *One Health Report of Antimicrobial Consumption and Resistance in Belgium*, op. cit.

4.2 Acties in verband met het voorschrijfgedrag

Wat het voorschrijven van antibiotica betreft, bestaan er twee soorten goede praktijken: op kwantitatief niveau en op kwalitatief niveau. Op kwantitatief niveau is het doel om het voorschrijven van antibiotica te verminderen door ze alleen indien nodig voor te schrijven. Kwalitatief is het de bedoeling om bepaalde antibiotica (bv. chinolonen) enkel als tweedelijsantibiotica voor te schrijven, d.w.z. pas nadat eerst een ander eerstelijsantibioticum is geprobeerd. Deze goede praktijk beperkt de blootstelling van bacteriën aan tweedelijsantibiotica en dus het risico op resistentie. Hierdoor blijft de werking van de antibiotica behouden. Daarnaast kunnen tweedelijsantibiotica, zoals chinolonen, “soms sterk invaliderende ongewenste effecten”¹⁶ veroorzaken.

Ten tijde van de initiële audit in 2022 was geen enkele doelstelling in verband met de goede praktijken voor het voorschrijven van antibiotica gehaald. Antibiotica werden in België te vaak voorgeschreven (2,6 keer meer dan in Nederland) en heel wat voorschriften waren niet in overeenstemming met de goede praktijken. Als gevolg daarvan werden te vaak meteen tweedelijsantibiotica voorgeschreven, zonder eerst een eerstelijsantibioticum voor te schrijven. Er waren dus extra maatregelen nodig om voorschrijvers aan te moedigen deze goede praktijken te volgen.

Aanbeveling 3

Evalueer de deelname van voorschrijvers die permanente bijscholingen volgen georganiseerd door de FOD Volksgezondheid of het RIZIV en evalueer in hoeverre die bijscholingen ertoe bijdragen dat voorschrijvers de goede praktijken beter navolgen.

FOD
Volksgezondheid,
RIZIV



Een manier om ervoor te zorgen dat voorschrijvers de goede praktijken volgen, is hen hierin op te leiden. Ten tijde van de initiële audit van 2022 konden voorschrijvers opleidingen over antibiotica volgen. Die waren echter niet verplicht en het RIZIV kon ook niet controleren of ze doeltreffend waren om de kwaliteit van de voorschriften te verbeteren. Het RIZIV beschikte nochtans over gegevens om de kwaliteit van de voorschriften per voorschrijver te beoordelen, en dus om de vooruitgang van het beleid op te volgen wat betreft de evolutie van het voorschrijfgedrag.

In antwoord op de opvolgingsvragenlijst laten de geauditeerden weten dat in 2025, net als in 2022, artsen die geaccrediteerd¹⁷ willen worden - en de financiële voordelen van die accreditatie willen ontvangen - opleidingen moeten volgen, waarin antibiotica al dan niet aan bod komen. In 2024 en 2025 kregen geaccrediteerde huisartsen die opleidingen volgen om een kwalitatief antibioticabeleid te bevorderen, bovendien extra stimulansen¹⁸. Het RIZIV organiseert die opleidingen echter niet zelf en heeft geen gegevens over de inhoud ervan.

Het Rekenhof stelt vast dat er vooruitgang is geboekt op het gebied van opleiding over goede praktijken, maar merkt ook op dat het RIZIV nog steeds geen informatie heeft over de effectiviteit van die opleidingen om de kwaliteit van antibioticavoorschriften te verbeteren.

¹⁶ Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), *Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium. Chinolonen*, op. cit.

¹⁷ RIZIV, *Accreditering van artsen en apothekers-biologen*, pagina geraadpleegd op 7 november 2025, www.riziv.fgov.be.

¹⁸ RIZIV, *Uw accreditering als arts of apotheker-bioloog verkrijgen of verlengen*, pagina geraadpleegd op 21 november 2025, www.riziv.fgov.be.

Aanbeveling 4

Maak de tools voor hulp bij het voorschrijven (*clinical decision support system* en sneltesten) toegankelijk voor al wie antibiotica voorschrijft, om de kwaliteit van de voorschriften te verbeteren; maak het inschakelen van infectieziekten specialisten mogelijk.

FOD
Volksgezondheid,
RIZIV



Om voorschrijvers te helpen de goede praktijken te volgen en de kwaliteit van de voorschriften te verbeteren, worden internationaal een aantal hulpmiddelen aanbevolen:

- de software *clinical decision support system*, die voorschrijvers helpt bij het kiezen van het juiste antibioticum;
- snellediagnosetests, die kunnen aantonen of een infectie bacterieel is of niet;
- de terugbetaling van raadplegingen bij een specialist in infectieziekten, die andere voorschrijvers advies kan geven over het voorschrijven van antibiotica.

Ten tijde van de initiële audit van 2022 was er van de toepassing van die hulpmiddelen nog geen sprake maar was die voor de geauditeerden enkel een denkpiste.

In antwoord op de opvolgingsvragenlijst lieten de geauditeerden weten de volgende acties te ondernemen:

- Een *clinical decision support system* type software zal eind 2025 beschikbaar zijn voor artsen en in 2027 voor tandartsen¹⁹.
- De invoering van snellediagnosetests is nog steeds gepland, maar zal afhangen van het beschikbare budget en de wensen op het terrein. In zijn antwoord op het ontwerp van opvolgingsverslag voegt het RIZIV eraan toe dat snellediagnosetests voor luchtweginfecties²⁰ momenteel worden geëvalueerd.
- Er is een budget voor de terugbetaling van raadplegingen bij infectiologen, maar hun advies voor ambulante patiënten wordt als minder prioritair beschouwd dan voor gehospitaliseerde patiënten.

De geauditeerden noemen budgettaire beperkingen als reden waarom de laatste twee hulpmiddelen mogelijk niet beschikbaar zijn voor ambulante patiënten. Infecties die resistent zijn tegen antibiotica veroorzaken echter aanzienlijke kosten, vooral in termen van ziekenhuisopname en de nawerkingen van infecties die moeilijk te genezen zijn. Adequate investeringen zouden de resistentie en dus de bijbehorende kosten kunnen verminderen.

Aanbeveling 5

Automatiseer de terugbetaling van alle antibiotica om te vermijden dat ze buiten het controledomein van het RIZIV vallen als de voorschrijver de terugbetalingsvoorwaarden niet in acht neemt.

Minister,
RIZIV



In 2017 en 2018 heeft een koninklijk besluit terugbetalingsvoorwaarden toegevoegd om het voorschrijven van tweedelijsantibiotica (zoals chinolonen) te beperken en ervoor te zorgen dat het voorschrijven volgens goede praktijken gebeurt. Als een voorschrijver niet aan deze voorwaarden voldoet, betaalt de patiënt sindsdien de volle pot voor het antibioticum zonder terugbetaling.

¹⁹ RIZIV, *Beslissingsondersteunend platform voor voorschrijvers: meer gepaste zorg en minder veiligheidsrisico's dankzij evidence-based ondersteuning*, pagina geraadpleegd op 22 oktober 2025, www.riziv.fgov.be.

²⁰ Salima Azahaf en andere, "Budget Impact Analysis of Implementing C-Reactive Protein Point-of-Care Testing to Aid Antibiotic Prescribing in Belgian Primary Care", *Applied Health Economics and Health Policy*, 2025/11/07 2025.

In zijn initiële audit van 2022 stelde het Rekenhof vast dat het RIZIV enkel gegevens had over geneesmiddelen die effectief werden terugbetaald en dan ook geen controle had over niet-terugbetaalde geneesmiddelen. Als de voorschrijver dus niet voldeed aan de voorwaarden voor terugbetaling, viel hij paradoxaal genoeg buiten de controle van het RIZIV. En aangezien die geneesmiddelen relatief goedkoop zijn, is de prijs van het geneesmiddel niet altijd een struikelblok voor de patiënt, die zelden in staat is om in te schatten of een voorschrift al dan niet terecht is. Bovendien is het aandeel niet-terugbetaalde chinolonen van alle verstrekte geneesmiddelen gestegen van 8 % in 2016 tot 61 % in 2019. De meeste voorschriften voor chinolonen vallen daarom buiten de controle van het RIZIV. De patiënt betaalt dubbel voor de gevolgen van het niet-naleven van de terugbetalingsvoorwaarden, ook al werd het antibioticum misschien onnodig voorgeschreven: hij krijgt geen terugbetaling maar wel een geneesmiddel voorgeschreven met soms zeer invaliderende bijwerkingen.

In antwoord op de opvolgingsvragenlijst vermeldde de geauditeerden geen enkele maatregel om het voorschrijven van antibiotica buiten de terugbetalingsvoorwaarden te controleren. Het percentage niet-terugbetaalde chinolonen dat wordt voorgeschreven, is in 2023, vergeleken met 2019 (61 %), nochtans weer gestegen (66 %). Daarnaast worden andere tweedelijsantibiotica (derdegeneratiecefalosporines²¹) nu bijna altijd voorgeschreven buiten de terugbetalingsvoorwaarden om (87 %). In totaal is het percentage niet-terugbetaalde antibiotica dat wordt voorgeschreven, gestegen van 11 % in 2019 naar 12 % in 2023²².

Aanbeveling 6 Verplicht de voorschrijvers van antibiotica de goede praktijken toe te passen of te vermelden waarom ze ervan afwijken.	Minister, FOD Volksgezondheid, RIZIV	
Aanbeveling 9 Zet acties op om de goede praktijken te evalueren en te controleren, zoals de actie die de DGEC al heeft uitgevoerd, in afwachting van bruikbare indicatoren van manifeste afwijking.	RIZIV	
Aanbeveling 10 Definieer de wettelijk voorgeschreven indicatoren van manifeste afwijking op basis van de beschikbare gegevens.	RIZIV	
Aanbeveling 11 Controleer voorschrijvers die de goede praktijken inzake antibiotica niet volgen via indicatoren van manifeste afwijking.	RIZIV	
Aanbeveling 14 Deel elk jaar het resultaat mee van de evaluatie van de navolging van de goede praktijken, door op nationaal niveau de evolutie te schetsen van het percentage voorschrijvers die de goede praktijken in acht nemen.	RIZIV	

Tijdens de initiële audit in 2022 ondernam het RIZIV onvoldoende effectieve actie om voorschrijvers de goede praktijken te doen naleven. Voorschrijvers ondervonden geen negatieve gevolgen als ze zich er niet aan hielden, terwijl dit gedrag negatieve gevolgen kan hebben voor de patiënten

²¹ Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), *Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium. Cefalosporines. Derde generatie*, pagina geraadpleegd op 7 november 2025, www.bcfi.be.

²² RIZIV, *Geneesmiddelenverbruik in openbare officina's. Antibiotica – Alle voorschrijvers. Analyse van de verdeling en van de evolutie van het verbruik in volumes en in uitgaven per verzekerde in België (analyses en tendensen per gewest, provincie en arrondissement) voor 2023*, op. cit.

(bijwerkingen), voor de bevolking in het algemeen (toename van antibioticaresistentie) en voor het milieu (vervuiling door verspilling van geneesmiddelen). De wet verplicht het RIZIV nochtans om toezicht te houden op overbodig voorschrijven. In 2022 werd die controle echter niet uitgevoerd omdat de benodigde indicatoren niet waren gedefinieerd.

In antwoord op de opvolgingsvragenlijst meldden de geauditeerden dat het RIZIV op 29 november 2023²³, op initiatief van zijn Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC), drie indicatoren voor goede praktijken heeft gepubliceerd. De eerste indicator is kwantitatief. Voor een huisarts betekent dit dat hij niet meer dan 23 % van de patiënten ouder dan veertien jaar (of meer dan 45 % van de patiënten van veertien jaar en jonger) antibiotica mag voorschrijven. De andere twee indicatoren zijn kwalitatief. Ze omvatten het beperken van het voorschrijven van tweedelijnsantibiotica (waaronder amoxicilline gecombineerd met clavulaanzuur²⁴, cefalosporines²⁵ en chinolonen) in vergelijking met eerstelijnsantibiotica.

De DGEC heeft de huisartsen op de hoogte gebracht van de inwerkingtreding van die indicatoren. Vervolgens stuurde de dienst naar elke huisarts een brief met informatie over zijn antibiotica-voorschriften van de afgelopen vijf jaar. Zo kon de arts zijn positie ten opzichte van de indicatoren beoordelen en zijn toekomstige voorschrijfgedrag aanpassen²⁶. Als een huisarts een van de indicatoren overschrijdt, kan de DGEC hem daar voortaan uitleg over vragen. Deze actie is een drukkingsmiddel om artsen aan te sporen de indicatoren voor goede praktijken te volgen. De wet²⁷ voorziet in andere acties die de DGEC kan ondernemen. Met gegevens over huisartsenvoorschriften kan de DGEC trends in voorschriften analyseren. Eind 2025 komt er een eerste evaluatie.

In zijn antwoord op het ontwerp van opvolgingsverslag bezorgde het RIZIV het Rekenhof cijfers die aantonen dat het aantal terugbetaalde antibioticavoorschriften in 2024 en tijdens de eerste vijf maanden van 2025 is gedaald. Uit de gegevens voor 2024 blijkt dat, vergeleken met 2023, de doses antibiotica die de huisartsen hebben voorgeschreven met 2,6 % daalden, terwijl de doses die door alle voorschrijvers werden voorgeschreven met slechts 0,6 % daalden. Aangezien de indicatoren voor goede praktijken enkel betrekking hebben op de huisartsen, doet de sterkere daling voor deze beroepsgroep vermoeden dat de maatregel wel efficiënt kan zijn. Of de andere maatregelen die ook op huisartsen waren gericht, een effect hebben gehad, valt echter onmogelijk te bepalen. Bovendien wijzen de laatst beschikbare gegevens (juni 2024-mei 2025) op een daling van 8 % van het aantal terugbetaalde antibiotica. Ook het aantal patiënten dat antibiotica kreeg, daalde met 8 %.

De maatregelen van de DGEC sluiten aan bij de aanbevelingen van het Rekenhof. Ze hebben echter enkel betrekking op huisartsen, terwijl andere voorschrijvers 25 % van de terugbetaalde an-

-
- 23 • RIZIV, *Antibiotica: indicatoren voor het doelmatig voorschrijven van antibiotica door huisartsen*, pagina geraadpleegd op 22 oktober 2025, www.riziv.fgov.be.
 • FOD Sociale Zekerheid, Indicatoren voor het voorschrijfgedrag van de artsen houder van het artsdiploma en de huisartsen voor antibiotica, *Belgisch Staatsblad*, 20 november 2023, www.justice.fgov.be.
- 24 Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), *Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium. Amoxicilline + clavulaanzuur*, pagina geraadpleegd op 3, december 2025, www.bcfi.be.
- 25 Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), *Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium. Cefalosporines*, pagina geraadpleegd op 7 november 2025, www.bcfi.be.
- 26 • RIZIV, *Antibiotica: indicatoren voor het doelmatig voorschrijven van antibiotica door huisartsen*, op. cit.
 • RIZIV, *Indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk – voorschrijven van antibiotica door huisartsen*, 8 december 2023, 3 p., www.riziv.fgov.be.
 • RIZIV, *Individuele feedback – indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk voor het voorschrijven van antibiotica door huisartsen*, 25 juni 2024, 9 p., www.riziv.fgov.be.
- 27 Artikel 142, §1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

tibiotica voorschrijven. Bovendien zijn de gegevens die worden gebruikt om het behalen van de indicatoren te berekenen nog steeds enkel gebaseerd op de terugbetaalde geneesmiddelen. De geauditeerden bezorgden het Rekenhof geen informatie over het percentage antibiotica dat zonder vergoeding werd afgeleverd in 2024 en 2025. Aangezien de DGEC geen controle uitoefent op voorschrijvers die buiten de terugbetalingsvoorwaarden om voorschrijven, kunnen voorschrijvers aan elke controle ontsnappen door voor te schrijven zonder zich aan deze voorwaarden te houden.

Aanbeveling 7

Behoud het voorschrijven van antibiotica die als laatste redmiddel worden gezien, voor aan infectieziektenspecialisten of koppel dat aan de voorwaarde dat zij advies verlenen (in zoverre zij daarvoor beschikbaar zijn).

Regering,
FOD
Volksgezondheid



In 2022 werd, in tegenstelling tot internationale en nationale aanbevelingen, geen enkel antibioticum dat als laatste redmiddel wordt gezien, voorbehouden aan specialisten, ondanks de aanzienlijke bijwerkingen van sommige van deze antibiotica, zoals de chinolonen.

In antwoord op de opvolgingsvragenlijst gaven de geauditeerden aan dat er procedures lopen om de terugbetalingsvoorwaarden van een reeks antibiotica die als laatste redmiddel worden gezien te herzien en de terugbetalingsaanvragen te beperken tot infectieziektenspecialisten. Slechts één antibioticum, amikacine, dat aanzienlijke bijwerkingen kan hebben²⁸, wordt terugbetaald na advies van een specialist.

In de praktijk kan elke arts (huisarts of specialist) deze antibiotica echter nog steeds voorschrijven buiten de terugbetalingsvoorwaarden om. In dit geval draagt de patiënt de risico's die gepaard gaan met de bijwerkingen van deze geneesmiddelen, ook al is het voorschrift mogelijk niet in overeenstemming met de goede praktijken. Bovendien betaalt de patiënt de volledige prijs van het geneesmiddel, terwijl de voorschrijver, die als enige verantwoordelijk is voor wat hij voorschrijft, gespaard blijft van negatieve gevolgen.

Aanbeveling 8

Ga na of er financiële stimulansen kunnen worden toegekend aan voorschrijvers die de goede praktijken inzake antibiotica navolgen.

RIZIV



Tijdens de initiële audit van 2022 ontvingen de voorschrijvers geen financiële stimulansen om hen aan te moedigen de goede praktijken rond antibiotica in acht te nemen.

In antwoord op de opvolgingsvragenlijst vermeldde de geauditeerden dat sinds 2023 het gebruik van twee barometers om zelf een type gedrag (voorschrijfgedrag bv.) te kunnen beoordelen, een van de voorwaarden is voor het ontvangen van een geïntegreerde praktijkpremie die elke huisarts kan aanvragen. De arts moet minstens twee van de drie voorgestelde barometers gebruiken. Een van de drie betreft het voorschrijven van antibiotica. Deze antibioticabarometer meet het aantal eerste- en tweedelijnsantibiotica (bv. chinolonen) dat door een arts wordt voorgeschreven voor luchtweg- of urineweginfecties. Deze barometer is een hulpmiddel voor zelfbeoordeling, waarmee

²⁸ Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), *Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium. Amikacine*, pagina geraadpleegd op 4 november 2025, www.bcfi.be.

artsen de manier waarop ze voorschrijven, kunnen vergelijken met die van andere artsen, via een feedback²⁹-systeem.

Het Rekenhof merkt op dat deze premie een stimulans is om antibiotica voor te schrijven volgens de regels van de goede praktijk.

Aanbeveling 12

Voer de verplichting in om de indicatie te vermelden op het antibioticavoorschrift.

Regering,
FOD
Volksgezondheid,
RIZIV



Tijdens de initiële audit van 2022 viel niet precies te evalueren of voorschrijvers de goede praktijken volgden omdat de indicatie waarvoor antibiotica werden voorgeschreven, niet op het voorschrift werd vermeld. Een indicatie is minder precies dan een diagnose omdat ze niet de exacte pathologie vermeldt (bv. het precieze soort longontsteking) maar een algemene term (bv. luchtweginfectie).

In antwoord op de opvolgingsvragenlijst verklaarden de geauditeerden dat het niet mogelijk is om de indicatie op het voorschrift verplicht te stellen, aangezien dit in strijd zou zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)³⁰.

Volgens het Rekenhof is deze restrictieve interpretatie van de Europese Verordening echter ongerechtvaardigd en ondermijnt ze een legitiem doel van volksgezondheid. Daarnaast beveelt het ECDC aan om de indicatie op de voorschriften voor antibiotica te vermelden³¹. Deze indicatie is trouwens verplicht in ten minste één Europees land, Denemarken³². Ze kan de apotheker ook helpen om de patiënt aanbevelingen te doen en valt onder het beroepsgeheim tussen arts en apotheker, zolang de patiënt zich er niet tegen verzet³³.

In zijn antwoord op het ontwerp van opvolgingsverslag voegde het RIZIV eraan toe dat “*de implementatie van software van het type ‘Clinical Decision Support System’ het mogelijk zal maken een direct verband te leggen tussen het voorschrift en de indicatie. Uiteindelijk zou elke zoekopdracht in de software, waarbij de indicatie expliciet wordt vermeld, kunnen worden gekoppeld aan een unieke identificatiecode die op het corresponderende voorschrift staat. In combinatie met de antibioticabarometer zal dit systeem helpen om de kwaliteit van de voorschriften beter op te volgen*”. Het RIZIV vermeldt niet of dit systeem al dan niet verplicht is, hoe de opvolging zal gebeuren en welke gevolgen het kan hebben voor voorschrijvers.

-
- 29 • Koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers.
- KU Leuven, *Antibiotica barometer*, pagina geraadpleegd op 22 oktober 2025, www.intego.be.
 - RIZIV, *Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde*, pagina geraadpleegd op 22 oktober 2025, www.riziv.fgov.be.
 - RIZIV, *Uitleg bij de voorwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde*, pagina geraadpleegd op 22 oktober 2025, www.riziv.fgov.be.
 - KU Leuven, *Antibiotica barometer*, op. cit.
 - Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), Nieuwe instrumenten om het rationeel voorschrijven van antibiotica door huisartsen te promoten, 21 december 2023, www.bcfi.be.
- 30 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), Publicatieblad van de Europese Unie L-119, 27 april 2016, p. 1-88, www.eur-lex.europa.eu.
- 31 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), *ECDC Country Visit to Belgium to Discuss Antimicrobial Resistance Issues. Mission report*, op. cit.
- 32 R. Aabenhus en andere, “Clinical indications for antibiotic use in Danish general practice: results from a nationwide electronic prescription database”, *Scand J Prim Health Care*, Jun 2017, volume 35, n° 2.
- 33 Orde van artsen, *De voorwaarden van de doctrine van het gedeeld beroepsgeheim*, www.ordomedic.be.

Aanbeveling 13

Evalueer via de inhoud van de voorschriften in hoeverre de voorschrijvers de goede praktijken toepassen.

RIZIV



Ten tijde van de initiële audit van 2022 was de indicatie niet beschikbaar om te beoordelen of voorschrijvers de goede praktijken volgden.

In antwoord op de opvolgingsvragenlijst vermeldde de geauditeerden dat de indicatie beschikbaar zal zijn via de geaggregeerde gegevens van de antibioticabarometer. Dankzij deze software bood het RIZIV artsen de mogelijkheid om hun voorschriften voor twee indicaties (luchtweg- en urineweginfectie) zelf te beoordelen. Met bijna 12.000 artsen die van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, lijken de huisartsen dit initiatief te hebben omarmd.

Deze barometer heeft echter alleen betrekking op huisartsen die er vrijwillig voor hebben ingeschreven. Bovendien zijn de resultaten nog niet beschikbaar. Dat zal pas het geval zijn nadat de gegevens zijn geaggregeerd en geanonimiseerd. Zonder het aggregatieniveau en het percentage betrokken voorschriften te kennen, kan het Rekenhof de uitvoering van zijn aanbeveling niet beoordelen.

4.3 Acties in verband met de aflevering

Aanbeveling 15

Controleer of de systemische antibiotica in de ambulante zorg altijd op vertoon van een voorschrift worden afgeleverd.

FAGG



Ten tijde van de initiële audit van 2022 waren er aanwijzingen dat in apotheken antibiotica zonder voorschrift, illegaal dus, worden afgeleverd.

In antwoord op de opvolgingsvragenlijst verklaarden de geauditeerden dat, op basis van de registratie door de apotheker van de voorschriften en afgeleverde geneesmiddelen, antibiotica niet zonder voorschrift worden verstrekt.

In een Europees onderzoek naar antibioticagebruik dat in 2022 werd gepubliceerd, zei echter 5 % van de respondenten (13 van de 262 ondervraagden in België) dat ze in een apotheek antibiotica zonder voorschrift hadden gekregen³⁴. Het Rekenhof beschikt dus niet over voldoende informatie om te bepalen of zijn aanbeveling wordt toegepast op alle antibiotica die apothekers afleveren.

In hun reactie op het ontwerp van opvolgingsverslag benadrukten de geauditeerden dat deze enquête een opiniepeiling is en geen kwantitatieve studie. Ze voegen eraan toe dat ze geen signalen hebben ontvangen vanop het terrein dat antibiotica zonder doktersvoorschrift worden afgeleverd. Voor het Rekenhof is het feit dat 13 van de 262 personen stelden een antibioticum zonder voorschrift te hebben ontvangen, een signaal vanop het terrein dat best onderzocht kan worden.

³⁴ • European Commission, *Special Eurobarometer 522. Antimicrobial Resistance. Fieldwork: February-March 2022. Report*, Publication Office of the European Union, 2022, 137 p., www.europa.eu.
• Europese Unie, *Speciale Eurobarometer SP522: Antimicrobiële weerstand. Dataset*, www.europa.eu.

Aanbeveling 16

Verplicht dat voor alle ambulant afgeleverde systemische antibiotica de exact benodigde hoeveelheid wordt voorgeschreven en afgeleverd.

Regering,
FAGG,
RIZIV



Tot 2019 is het aantal doses antibiotica per verpakking (bv. een doos of flacon met tabletten) voortdurend gestegen, waardoor onnodig antibiotica worden verstrekt wanneer het aantal doses in de verpakking groter is dan het aantal benodigde doses. Een oplossing is om alleen de exacte hoeveelheid af te leveren en de verpakkingen indien nodig te openen. In 2022 gingen alleen RVT's en ziekenhuizen op die manier tewerk.

In antwoord op de opvolgingsvragenlijst vermeldde de geauditeerden dat de aflevering van de exacte hoeveelheid antibiotica is opgenomen in het regeerakkoord van 4 februari 2025, dat streeft naar “een aflevering per behandelingstermijn”³⁵. Het kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid buigt zich momenteel over de nodige wetteksten. De geauditeerden wezen er echter op dat de uitvoering van de maatregel complex is. Dit impliceert immers een aanpassing van de regelgeving voor voorschrijvers en apothekers. Apothekers zouden bv. op een andere basis dan per verkochte verpakking moeten worden vergoed.

In hun antwoord op het ontwerp van opvolgingsverslag kondigden de geauditeerden aan dat deze maatregel in principe op 1 april 2026 in werking moet treden, dankzij de samenwerking tussen de betrokken administraties, de belanghebbenden en de beleidscel.

4.4 Nationaal actieplan voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie

Aanbeveling 17

Stel specifieke actieplannen op voor de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, en preciseer daarin de toegewezen middelen en voeg een evaluatie van de doeltreffendheid van de acties toe om de Smart-doelstellingen te bereiken.

FOD
Volksgezondheid,
RIZIV

**Aanbeveling 18**

Voeg Smart-doelstellingen op korte en middellange termijn toe, gedetailleerd per instelling, om het aandeel voorschriften dat voldoet aan goede praktijken te verhogen.

FOD
Volksgezondheid,
RIZIV

**Aanbeveling 19**

Neem de acties uit aanbevelingen 3 tot 16 op in het nationaal plan.

FOD
Volksgezondheid,
RIZIV

**Aanbeveling 20**

Voorzie in een toetsing van de doeltreffendheid van elke actie uit het nationaal plan aan de Smart-doelstellingen.

FOD
Volksgezondheid,
RIZIV



In 2022 werd een vierjarig nationaal actieplan voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (waaronder antibiotica) vooropgesteld voor de periode 2020 tot 2024³⁶. De operationele doelstellingen waren niet erg specifiek wat betreft het voorschrijven en afleveren van antibiotica in de ambulante zorg. Bovendien wees niets erop dat het in het plan ging om *evidencebased* acties en dat ze ook efficiënt zouden zijn. Het risico van middelenverspilling door de toepassing van ondoeltreffende maatregelen viel dus niet uit te sluiten, vooral omdat het plan niet voorzag in een evaluatie

³⁵ Parl. St. Kamer, 4 februari 2025, DOC 56 0020/001, Regeringsverklaring. Regeerakkoord, www.dekamer.be.

³⁶ FOD Volksgezondheid en andere, *Belgisch nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie 2020-2024*, op. cit.

van de doeltreffendheid van die maatregelen. Bovendien beschikten de FOD Volksgezondheid en het RIZIV niet over een specifiek actieplan met daarin de maatregelen die hen betroffen, de middelen die ervoor werden uitgetrokken en de evaluatie van de doeltreffendheid ervan.

In hun antwoord op de opvolgingsvragenlijst bevestigden de geauditeerden dat het nationaal plan 2020-2024 niet was ontworpen om de doeltreffendheid van elke maatregel te kunnen evalueren en dat een evaluatie van alle maatregelen niet was gepland. Wel zijn gerichte evaluaties gepland voor een project voor het beheer van luchtweginfecties en voor beslissingsondersteunende software.

In hun antwoord op de opvolgingsvragenlijst vermeldde de geauditeerden geen specifieke actieplannen voor de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. De FOD heeft de maatregelen die hem aanbelangen echter geïntegreerd in het operationele plan van zijn DG Gezondheidszorg (DGG), met een driemaandelijks opvolging en rapportering (meegedeeld aan het Rekenhof). Het RIZIV heeft een structuur uitgewerkt voor halfjaarlijkse rapportering aan het directiecomité. Bovendien publiceert Sciensano, in het verlengde van dit plan, sinds 2021 elk jaar een 'Belmap-rapport', waarin onder meer de evolutie van het aantal terugbetaalde antibiotica en het percentage antibiotica dat zonder terugbetaling wordt afgeleverd, aan bod komen³⁷. Gegevens over terugbetaalde antibiotica zijn ook beschikbaar op de [website](#) van het ECDC. Afgezien van deze elementen is het plan zelf niet aangepast of geëvalueerd sinds de publicatie ervan in 2021³⁸.

Daarnaast stellen de geauditeerden dat een nieuw nationaal plan 2026-2030 zich in de valideringsfase bevindt. Daarin zou rekening worden gehouden met de aanbevelingen van het Rekenhof en zouden er *smart*-doelstellingen worden aan toegevoegd. Een evaluatie van de gedane investeringen is gepland. Het volgende nationale plan zal ook gebaseerd zijn op :

- de aanbevelingen van het ECDC³⁹;
- een evaluatie van het plan, die grote tekortkomingen op het gebied van monitoring en evaluatie aan het licht bracht⁴⁰;
- gerichte evaluaties van het vorige plan.

5 Conclusies

Van de twintig aanbevelingen die het Rekenhof tijdens zijn initiële audit van december 2022 deed, zijn er zes uitgevoerd, tien gedeeltelijk uitgevoerd of in uitvoering, twee niet opgevolgd en twee niet te beoordelen.

Over het algemeen gaat de omkadering van het voorschrijven en afleveren van antibiotica erop vooruit. Zo zijn heel wat van de door het Rekenhof aanbevolen maatregelen uitgevoerd of gepland. Belangrijke maatregelen richten zich tot alle huisartsen, de belangrijkste voorschrijvers. Eind 2023 werden indicatoren voor goede praktijken gepubliceerd om toezicht te houden op huisartsen die antibiotica voorschrijven zonder goede klinische praktijken te volgen. Wat alleen de terugbetaalde antibiotica betreft, tonen de RIZIV-gegevens een daling van 8 % in doses antibiotica

³⁷ Sciensano, Belmap 2024, *One Health Report of Antimicrobial Consumption and Resistance in Belgium*, op. cit.

³⁸ FOD Volksgezondheid en andere, *Belgisch nationaal actieplan "One Health" voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie 2020-2024*, op. cit.

³⁹ European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), *Country Report: ECDC Public Health Emergency Preparedness Assessment for Belgium, 2024. Under Article 8 of the Regulation (EU) 2022/2371*, Stockholm, juli 2024, 32 p., www.ecdc.europa.eu.

⁴⁰ Jay Patel en andere, "Measuring the global response to antimicrobial resistance, 2020-21: a systematic governance analysis of 114 countries", *The Lancet Infectious Diseases*, 2023, volume 23, n° 6, www.thelancet.com.

voor de periode van juni 2024 tot mei 2025 in vergelijking met 2019. Uit de gegevens voor 2024 blijkt ook dat de daling vooral betrekking heeft op huisartsen, wat zou kunnen wijzen op de doeltreffendheid van deze maatregel.

Daarnaast wordt verwacht dat wijzigingen in de regelgeving zullen zorgen voor toepassing van een andere aanbeveling, met name het afleveren van de exact benodigde hoeveelheid, die het aantal onnodig verstrekte antibiotica moet beperken.

Zolang er echter geen controles zijn op het aantal afgeleverde, maar niet-terugbetaalde antibiotica, zullen voorschrijvers de RIZIV-controles kunnen omzeilen door antibiotica voor te schrijven buiten de terugbetalingsvoorwaarden om. Het aandeel niet-terugbetaalde antibiotica ten opzichte van terugbetaalde antibiotica neemt tussen 2019 (11 %) en 2023 (12 %) toe. In 2023 werden sommige antibiotica met mogelijk ernstige bijwerkingen zelfs meestal voorgeschreven buiten de terugbetalingsvoorwaarden om. Aangezien deze voorwaarden bedoeld zijn om de naleving van goede klinische praktijken af te dwingen, is het voorschrijven van die antibiotica buiten de terugbetalingsvoorwaarden om mogelijk niet in overeenstemming met de voorwaarden. Zolang er geen controles zijn, zullen antibiotica afgeleverd blijven worden zonder de goede praktijken na te leven, met het risico op toename van de bacteriële resistentie.

Voorschrijven buiten de terugbetalingsvoorwaarden om heeft negatieve gevolgen voor de patiënt. Die betaalt immers de volledige prijs van het antibioticum en loopt het risico te worden blootgesteld aan de bijwerkingen van een antibioticum dat misschien niet voorgeschreven had mogen worden. De algemene bevolking betaalt ook de prijs voor die gebrekkige naleving van goede praktijken, door de toename van antibioticaresistente infecties en de daaruit voortvloeiende kosten voor de sociale zekerheid.

Dit verslag is enkel elektronisch beschikbaar,
in het Nederlands en het Frans, op rekenhof.be.



WETTELIJK DEPOT

D/2026/1128/03

COVERFOTO

Shutterstock

ADRES

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

TEL.

+32 2 551 81 11

rekenhof.be